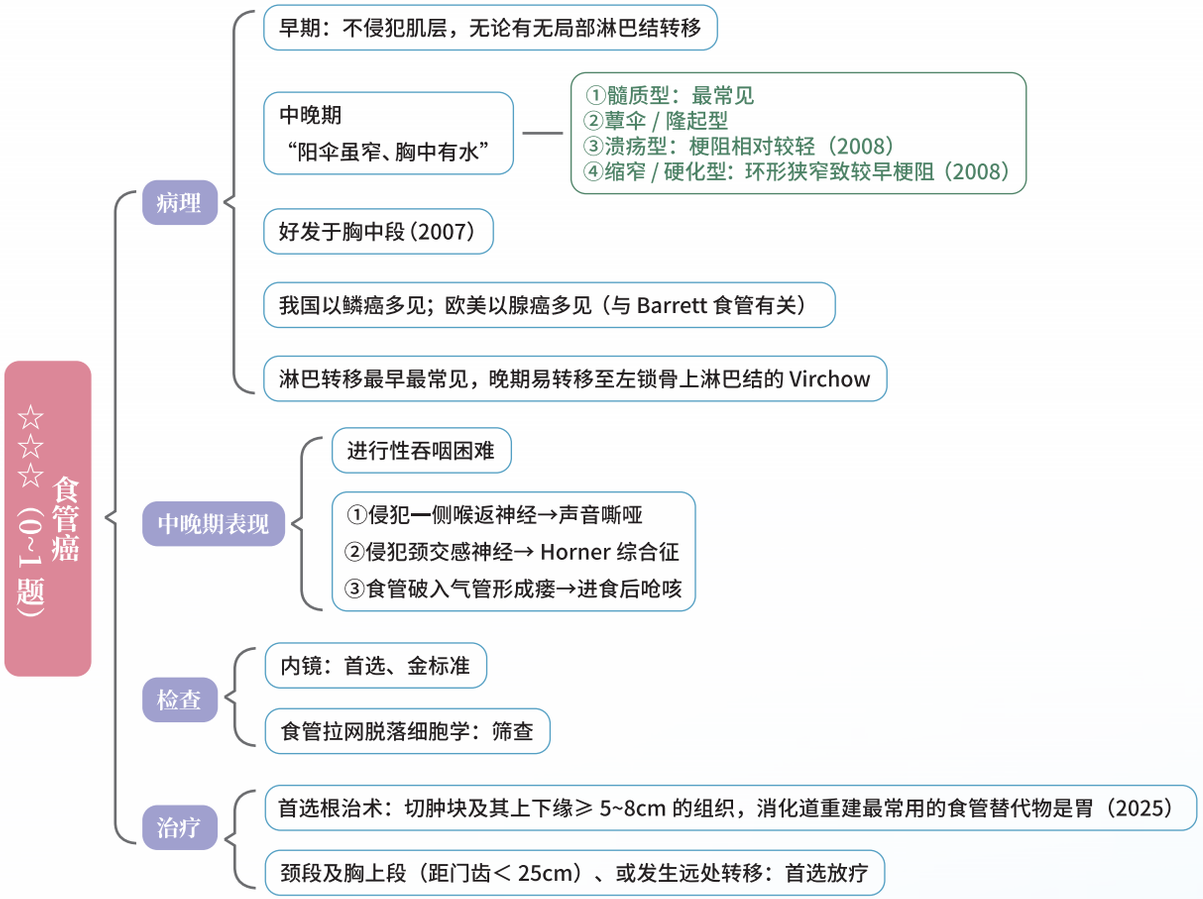

☆☆☆食管癌（0~1题）
病理
早期：不侵犯肌层，无论有无局部淋巴结转移
中晚期
“阳伞虽窄、胸中有水”
①髓质型：最常见
②蕈伞 / 隆起型
③溃疡型：梗阻相对较轻（2008）
④缩窄 / 硬化型：环形狭窄致较早梗阻（2008）
好发于胸中段（2007）
我国以鳞癌多见；欧美以腺癌多见（与 Barrett 食管有关）
淋巴转移最早最常见，晚期易转移至左锁骨上淋巴结的 Virchow
中晚期表现
进行性吞咽困难
①侵犯一侧喉返神经→声音嘶哑
②侵犯颈交感神经→ Horner 综合征
③食管破入气管形成瘘→进食后呛咳
检查
内镜：首选、金标准
食管拉网脱落细胞学：筛查
治疗
首选根治术：切肿块及其上下缘≥ 5~8cm 的组织，消化道重建最常用的食管替代物是胃（2025）
颈段及胸上段（距门齿＜ 25cm）、或发生远处转移：首选放疗